

Fases del trabajo de parto

1. Introducción y relevancia clínica

El **trabajo de parto (TP)** es el proceso fisiológico mediante el cual se produce la **dilatación y borramiento del cuello uterino**, el **descenso del feto** y la **expulsión del recién nacido y la placenta**.

Comprender su fisiología, fases y parámetros normales permite:

- **Diferenciar parto verdadero de falso trabajo de parto.**
- **Reconocer distocias (anormalidades del progreso).**
- **Tomar decisiones seguras sobre intervenciones obstétricas.**

□ En EUNACOM suelen aparecer casos clínicos de mujeres con contracciones regulares, cambios cervicales o alteración en la velocidad de dilatación (diagnóstico diferencial entre fase latente y activa).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El inicio del trabajo de parto resulta de una **compleja interacción entre factores hormonales, mecánicos y bioquímicos**.

Principales mecanismos:

1. **Aumento del tono uterino** por incremento de la **sensibilidad a la oxitocina**.
 2. **Aumento de prostaglandinas (PGE_2 y $PGF_2 \alpha$)** en el cuello y miometrio.
 3. **Maduración cervical** (reblandecimiento y borramiento).
 4. **Formación del segmento uterino inferior.**
-

Participación hormonal:

Hormona	Acción principal
Oxitocina	Estimula contracciones uterinas regulares
Prostaglandinas	Maduran el cuello y potencian contracciones
Estrógenos	Aumentan la expresión de receptores de oxitocina
Progesterona	Mantiene quiescencia uterina hasta fases finales
Cortisol fetal	Contribuye a la maduración placentaria y uterina

3. Definición de trabajo de parto

Trabajo de parto verdadero:

Presencia de **contracciones uterinas regulares, dolorosas y efectivas**, que **producen modificaciones cervicales progresivas** (borramiento y dilatación).

Trabajo de parto falso (pródromos):

- Contracciones irregulares.
 - No hay cambios cervicales.
 - Se alivia con reposo o hidratación.
-

4. Fases del trabajo de parto (Guía Perinatal MINSAL 2023)

El trabajo de parto se divide en **3 períodos** principales, cada uno con fases específicas.

I. Primer período: dilatación

Va desde el **inicio del trabajo de parto activo** hasta la **dilatación completa (10 cm)**.

A. Fase latente

- **Dilatación:** hasta 4–5 cm.
- **Contracciones:** irregulares, cada 5–10 min, duración 30–40 s.
- **Duración:**
 - Primíparas: <20 h.
 - Multíparas: <14 h.

Durante esta fase, el cuello se borra y se inicia la dilatación progresiva.

- Es importante diferenciar fase latente prolongada de trabajo de parto falso. En la latente hay borramiento y dilatación cervical, aunque lenta.

B. Fase activa

- **Dilatación inicial:** 4–5 cm hasta 10 cm.
- **Contracciones:** regulares, cada 2–3 min, duración 45–60 s, intensidad moderada a fuerte.
- **Velocidad de dilatación:**
 - Primíparas: ≥ 1 cm/h.
 - Multíparas: $\geq 1,5$ cm/h.

Se subdivide en tres subfases:

Subfase	Característica
Aceleración	De 4 a 6 cm (inicio del trabajo activo)

Máxima pendiente De 6 a 8 cm (dilatación rápida)

Desaceleración De 8 a 10 cm (preexpulsivo)

II. Segundo período: expulsivo

Desde la **dilatación completa (10 cm)** hasta la **salida completa del feto**.

Características:

- Contracciones muy intensas y frecuentes (cada 1–2 min).
- Sensación de pujo y presión rectal.
- Duración:
 - Primíparas: ≤ 2 h (hasta 3 h con analgesia epidural).
 - Multíparas: ≤ 1 h (hasta 2 h con epidural).

Etapas del descenso fetal:

1. **Encajamiento:** paso del diámetro biparietal por el estrecho superior.
2. **Descenso:** avance del feto a través del canal del parto.
3. **Flexión:** mentón hacia tórax.
4. **Rotación interna:** occipucio hacia sínfisis púbica.
5. **Extensión:** salida de la cabeza.
6. **Rotación externa:** alineación con hombros.
7. **Expulsión:** salida del cuerpo.

☐ La **rotación interna y flexión** son esenciales para el progreso normal.
Su alteración → **distocias de posición**.

III. Tercer período: alumbramiento

Desde el **nacimiento del feto** hasta la **expulsión de la placenta y membranas**.

Duración normal: <30 minutos.

Signos de desprendimiento placentario:

- Chorro de sangre vaginal.
- Elevación del fondo uterino.
- Alargamiento del cordón.
- Cambio de forma uterina (más globular).

Manejo activo (MINSAL):

1. **Administrar oxitocina 10 UI IM** tras el nacimiento del hombro anterior.
2. **Tracción controlada del cordón** con contracción uterina.
3. **Masaje uterino inmediato** tras expulsión placentaria.

Este manejo reduce la hemorragia posparto en más de un 50%.

5. Evaluación del progreso del parto: partograma

El **partograma** es la herramienta principal para registrar el progreso del trabajo de parto.

Permite identificar precozmente desviaciones o estancamientos.

Componentes:

- Dilatación cervical vs tiempo.
- Descenso fetal.
- Frecuencia y duración de contracciones.
- Frecuencia cardíaca fetal.
- Medicamentos, líquidos, signos vitales maternos.

Líneas de referencia:

- **Línea de alerta:** dilatación mínima esperada (1 cm/h).
- **Línea de acción:** 4 h a la derecha de la línea de alerta; si se cruza → intervenir o derivar.

□ Si el progreso de dilatación se detiene ≥ 2 h en fase activa → **diagnóstico de detención del trabajo de parto.**

6. Exámenes y monitoreo

Examen / control	Objetivo
Tacto vaginal cada 4 h	Evaluar dilatación y descenso
Monitorización fetal (Doppler / cardiotocografía)	Detectar sufrimiento fetal
PA, pulso, temperatura materna	Control hemodinámico
Control de diuresis	Evitar retención urinaria
Amniotomía	Puede acelerar el trabajo si membranas íntegras

7. Conductas obstétricas según fase

Fase	Conducta recomendada
------	----------------------

Latente	Observación, hidratación, analgesia leve, evitar intervenciones innecesarias
Activa	Monitorización continua, manejo con partograma, apoyo emocional
Expulsivo	Pujo dirigido, episiotomía selectiva, evitar maniobras forzadas
Alumbramiento	Manejo activo con oxitocina, control del sangrado

8. Complicaciones asociadas

Complicación	Momento	Manejo
Trabajo de parto prolongado	Fase activa	Evaluar causa: pelvis, feto, contracciones
Falla de progreso	Activa o expulsivo	Oxitocina o cesárea según caso
Sufrimiento fetal agudo	Cualquier fase	Interrupción inmediata (cesárea)
Inercia uterina	Expulsivo	Oxitocina o cesárea
Hemorragia posparto	Alumbramiento	Manejo activo + uterotónicos

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El trabajo de parto verdadero se diagnostica por **contracciones regulares + cambios cervicales**.
2. Fase **latente**: hasta 4 cm. Fase **activa**: desde 4 cm hasta dilatación completa.
3. Velocidad de dilatación normal: **≥1 cm/h** en primíparas.
4. **Partograma**: herramienta clave para evaluar progreso.
5. **Manejo activo del alumbramiento**: oxitocina + tracción controlada + masaje uterino.
6. **Duración normal**: <20 h primípara, <14 h multípara.
7. **Signos de desprendimiento placentario**: chorro de sangre + elevación uterina + alargamiento del cordón.



Errores comunes

- Confundir contracciones irregulares (falsas) con trabajo de parto real.
- No registrar partograma o ignorar línea de acción.
- No usar oxitocina tras el parto (aumenta riesgo de hemorragia posparto).
- Realizar tactos vaginales muy frecuentes (riesgo de infección).
- Forzar el pujo antes de dilatación completa.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Trabajo de parto verdadero**: contracciones regulares y cambios cervicales.
2. **Fase latente**: hasta 4 cm; **fase activa**: 4–10 cm.
3. **Velocidad mínima normal**: 1 cm/h (primíparas).
4. **Partograma** es fundamental para el control del progreso.

5. **Expulsivo:** desde 10 cm hasta el nacimiento; duración ≤ 2 h (primípara).
6. **Manejo activo del alumbramiento** previene hemorragia posparto.
7. **Oxitocina y control uterino post alumbramiento** son medidas vitales.